認定調査票(概況調査)

テスト用架空事例

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月　日　(テスト用)
実施場所	回復期リハビリテーション病院
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	新規申請(退院前)		
対象者氏名	中村 ハル子 (なかむら はるこ)	性別	女
生年月日	昭和22年(1947年)9月20日	年齢	79歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

利用なし。回復期リハビリテーション病院に入院中で、来月退院予定。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	夫は3年前に他界。長男(55歳・会社員)、長男の妻(53歳・平日9〜17時パート勤務)、孫(高校生)と同居。日中の平日9〜17時は本人ひとりになる。長女(50歳)は市内在住で週1回程度来られる。
居住環境	持ち家の木造2階建て。本人の部屋は1階の和室(布団)。トイレは洋式だが手すりなし。浴室は浴槽が深く、出入口に段差(約12cm)。廊下は幅が狭い。玄関の上がり框は約30cm。
使用している機器等	病院で四点杖・短下肢装具(右)を使用中。
生活歴	専業主婦として家族の食事を40年以上作ってきた。料理が得意で、孫の弁当作りが生きがいだった。地区の婦人会の役員も務めていた。
本人・家族の主訴	本人:「もう一度、自分で台所に立ちたい。孫に料理を作ってあげたい。」(言葉が出にくく、ゆっくりと時間をかけて話す) 長男の妻:「日中ひとりにするのが不安。でも仕事は続けたい。できることは手伝います。」 長男:「母がリハビリを続けられる環境を整えてやりたい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	ない　左上肢　(右上肢)　左下肢　(右下肢)　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない　(肩関節)　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-5 座位保持	(できる)　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-7 歩行	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-10 洗身	介助されていない　(一部介助)　全介助　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助　(全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える　目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない　見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通)　普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる　ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-2 移動	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる)　見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-9 整髪	介助されていない　(一部介助)　全介助
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上)　月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる)　ときどき伝達できる　ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる)　できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる)　できない
3-4 短期記憶	(できる)　できない
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	(できる)　できない
3-7 場所の理解	(できる)　できない

3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある
3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	ない　(ときどきある)　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　(一部介助)　全介助
5-2 金銭の管理	介助されていない　(一部介助)　全介助
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる))　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)　□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置　□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　(A1)　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　(Ⅰ)　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-1 右上下肢に麻痺あり。右手は物を軽く握る程度で、細かい動作はできない。右足は装具をつけて支えにできる。 1-2 右肩の挙上制限あり(90度程度まで)。 1-3・1-4 病院のベッド柵につかまって寝返り・起き上がりをしている。退院後は自宅の布団になる予定。 1-7 四点杖と右短下肢装具を使い、病棟内を見守りで歩いている。20m程度で休憩が必要。 1-10 入浴は病院の浴室で、左手で前面を洗い、背中・左腕・足先は看護職員が洗っている。 1-11 左手だけでは爪切りが使えず、すべて看護職員が切っている。
第2群 生活機能	2-1 ベッドから車いす・トイレへの移乗は、柵につかまって自分で行うが、ふらつきがあるため職員が見守っている。 2-2 病棟内の移動は四点杖で、転倒予防のため職員が付き添って見守っている。 2-4 左手でスプーン・フォークを使い、自分で食べている。食べこぼしは少しある。 2-9 左手で整髪するが後ろ側が整わないため、職員が直している。 2-10・2-11 上衣は右袖を通すところ、ズボンは右足を通して引き上げるところを職員が介助。それ以外は自分で行う。 2-12 リハビリで週3回、病院の外を歩く練習をしている。
第3群 認知機能	3-1 言葉がすぐに出てこないことがあるが、時間をかければ自分の考えを伝えられる。調査の質問にもすべて答えた。
第4群 精神・行動障害	4-3 リハビリが思うように進まない時に涙を流すことが週に1〜2回ある(病棟看護師より)。「家族に迷惑をかける」と話す。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬は看護師が1回分ずつ渡し、自分で飲んでいる。退院後は長男の妻が一包化した薬をセットする予定。 5-2 入院中の小遣いは長男が管理している。 5-5 入院中のため買物は行っていない。必要な物は長男の妻が購入している。 5-6 入院中のため調理は行っていない(全介助)。作業療法で片手での調理練習を始めている。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	中村 ハル子　(女・79歳)　医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 脳梗塞(左中大脳動脈領域)後遺症:右片麻痺、運動性失語(軽度)	令和8年(2026年)6月
2. 心房細動	約8年前
3. 高血圧症	約20年前

(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	令和8年6月に脳梗塞を発症し急性期病院で治療後、回復期リハビリテーション病院へ転院。理学・作業・言語療法により、歩行は見守りで四点杖歩行が可能となった。心房細動に対し抗凝固薬を内服中で、転倒時の出血に注意が必要。 投薬:抗凝固薬、降圧薬2種、胃薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):A1　認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅰ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:いくらか困難(失語による)
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	抑うつ傾向(軽度)
(5)身体の状態	利き腕:右(現在は左手を使用)/身長150cm・体重48kg/右上下肢の麻痺(中)/右肩関節の拘縮(軽)/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:介助があればしている/車いす:主に他人が操作(長距離のみ)/歩行補助具・装具:四点杖、右短下肢装具を使用
(2)栄養・食生活	食事行為:自立ないし何とか自分で食べられる/栄養状態:良好/留意点:塩分制限
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	転倒・骨折、移動能力の低下、意欲低下 → リハビリの継続、住環境の整備、転倒時の出血に注意
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	血圧:収縮期血圧160以上で運動を控える。移動:転倒に注意(抗凝固薬内服中)。運動:麻痺側の肩を無理に引っぱらない。
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

退院後もリハビリを継続することで、屋内歩行の自立と家事動作の一部再獲得が期待できる。退院前に自宅の環境調整を勧める。